

Schemat *wstydu*

Wstyd dorosłego pacjenta rzadko zaczyna się w dorosłości. Najczęściej ma korzenie w dzieciństwie — schemat, który mówi „jestem zły” przez całe życie.

CZAS: 30 min refleksja Po pracy z autosympatią

ŹRÓDŁO: Young, Klosko & Weishaar (2003); Bernstein i wsp. (2007); Roediger (2018)

JAK UŻYWAĆ

Terapia schematów (Young, Klosko & Weishaar 2003) opisuje **schemat wstydu / wadliwości** — głębokie przekonanie: „*jestem wadliwy/-a, niegodny/-a miłości, jeśli ktoś mnie pozna, odrzuci mnie*”. Karta: 1) **korzenie w dzieciństwie**, 2) **5 trybów** w PPU, 3) rozpoznanie u siebie, 4) interwencje (limited reparenting, dialogi krzesel, rescripting).

DLACZEGO TO DZIAŁA

Young (2003): **schemat wstydu** kształtuje się w dzieciństwie (3-8 lat) w odpowiedzi na: krytykę, porównania, wykluczenie, upokorzenie. Staje się **filtrem percepcji** — pacjent w dorosłości szuka dowodów potwierdzających schemat. PPU jest często *uruchamiane* przez aktywację schematu (krytyka → „*jestem wadliwy*” → szukanie ulgi → porno) i *potwierdza* schemat. Bernstein i wsp. (2007): pacjenci z PPU mają **3-5x wyższe** nasycenie schematem wstydu niż populacja ogólna. Praca z schematem zmienia *podłoże*, nie tylko zachowanie.

01 = Korzenie schematu wstydu w dzieciństwie

Krytyka i porównania. Stała krytyka, porównania z lepszym rodzeństwem. „*Nie wystarczam*”.

Wstyd na ciele / seksualności. Wczesne: „*to brudne*”. Ciało jako źródło wstydu.

Wykluczenie społeczne. Odrzucenie przez rówieśników, przemoc rówieśnicza.

Doświadczenia upokorzenia. Publiczne ośmieszenie. „*Jeśli widoczny — zranią*”.

Niedostępność emocjonalna rodzica. Rodzic „zimny”. „*Nie zasługuję*”.

Wykorzystanie / nadużycie. Naruszenie granic — emocjonalne, fizyczne, seksualne.

02 ● Pięć trybów schematu wstydu w PPU

TRYB	GŁOS W GŁOWIE	FUNKCJA W PPU
<i>Wrażliwe Dziecko</i>	„Boli, jestem samotny/-a, nikt mnie nie kocha”	Ból, którego nikt nie ukoił. Szuka ulgi — porno daje natychmiastową.
<i>Karzący Rodzic</i>	„Jesteś zboczeńcem, beznadziejny, zasługujesz na cierpienie”	Wewnętrzny głos krytyczny. Po epizodzie — biczowanie psychiczne. Napędza cykl wstydu.
<i>Odcięty Obrońca</i>	„Nic nie czuję, robię co chcę, jest mi obojętne”	Znieczulenie się — w trakcie epizodu PPU. Odciecie od bólu Dziecka.
<i>Posłuszny Poddany</i>	„Robię to, czego się ode mnie oczekuje, ukrywam co czuję”	Maska normalności w życiu zewnętrznym, ukryte PPU jako jedyny obszar „autentyczny”.

TRYB	GŁOS W GŁOWIE	FUNKCJA W PPU
<i>Zdrowy Dorosły</i>	<i>„Cierpię i to jest ludzkie, zasługuję na pomoc, mogę się zmieniać”</i>	Tryb docelowy. Reguluje wszystkie inne — jest „mądrym rodzicem” dla swojego Dziecka.

03 Rozpoznanie u siebie — autorefleksja

KIEDY PIERWSZY RAZ POJAWIŁ SIĘ WSTYD
DOTYCZĄCY CIAŁA / SEKSUALNOŚCI

— *wiek, sytuacja*

GŁOS KARZĄCEGO RODZICA — CZYJ TO GŁOS
PIERWOTNIE

— *kto mówił podobne rzeczy w dzieciństwie*

CZEGO POTRZEBOWAŁEM/-AM WTEDY, CZEGO NIE
DOSTAŁEM/-AM

— *bezpieczeństwa, akceptacji, uwagi*

W JAKICH SYTUACJACH AKTYWUJE SIĘ KARZĄCY
RODZIC DZISIAJ

— *wyzwalacze*

04 Interwencje schematerapeutyczne — wstęp

1 • LIMITED REPARENTING

Terapeuta staje się tymczasowo „dobrym rodzicem” — daje to, czego pacjent nie dostał w dzieciństwie: akceptację, uwagę, nieoceniającą bliskość. W relacji terapeutycznej.

2 • DIALOGI KRZESEŁ

Praca z trybami: pacjent rozmawia z Wrażliwym Dzieckiem (siedząc na jednym krześle), z Karzącym Rodzicem (na drugim), uczy się Zdrowego Dorosłego (na trzecim). Wymaga doświadczonego terapeuty.

3 • PRZEPISYWANIE OBRAZÓW (IMAGERY RESCRIPTING)

Powrót w wyobraźni do sytuacji z dzieciństwa, w której pojawił się wstyd. Pacjent (jako Zdrowy Dorosły lub z pomocą terapeuty) *interweniuje* w scenę — chroni Dziecko, mówi co potrzebowało usłyszeć.

Ważne: praca z schematami wymaga **doświadczonego terapeuty** przeszkolonego w terapii schematów (certyfikat ISST). Karta ma walor *edukacyjny* — by zrozumieć źródło, nie wykonać pełną terapię samodzielnie. Praca z traumą rozwojową i schematami w dzieciństwie jest *głęboka* i wymaga bezpiecznej relacji terapeutycznej.

Klucz: Roediger (2018) podkreśla, że w PPU schemat wstydu jest **często fundamentem problemu**, nie samym objawem. Klasyczna CBT pracuje z poziomu zachowania (porno) i myśli („*chcę przestać*”) — ale schemat pozostaje aktywny. Po jakimś czasie schemat *tworzy nowe objawy*: jeśli porno usunięte, schemat znajdzie inną ścieżkę (alkohol, pracobolizm, zaburzenia odżywiania). Praca z schematem na poziomie głębokim — przez doświadczeniowe interwencje (krzesła, rescripting, limited reparenting) — zmienia *fundament*. Po 1-2 latach terapii schematu pacjent doświadcza: „*już nie czuję się fundamentalnie wadliwy/-a*”. Wtedy PPU traci motor.